

Lundi 17 mars 2025

Omarthrose

I. Généralités

- Arthrose de l'épaule : plus rare qu'à la hanche ou au genou
- Longtemps bien tolérée, par mécanisme de compensation articulaire
- Articulation ne prenant en charge qu'une partie de la mobilité de la ceinture scapulaire
-

II. Omarthrose centrée

A. Définition

- Tête humérale en regard de la glène par absence de rupture de la coiffe des rotateurs ⇒ omarthrose centrée

B. Anatomie pathologique

- Lésion arthrosique non spécifique
- Usure cartilagineuse et remaniement scléro-géodique de l'os sous-chondral
- Réaction ostéophytique en collerette céphalique sous forme d'une goutte à la partie inférieure de la tête
- Usure glène postérieure, augmentant sa rétroversion

C. Formes étiologiques

1. Omarthrose primitive

- Femme +++ (75%)
- Bilatérale sans être symétrique (1/2 cas)
- Atteinte côté dominant (80%)
- Survient sur terrain poly arthrosique
- Evolution souvent lente, aggravation par paliers brutaux
- Forme évolutive particulière : omarthrose destructive rapide, évolutivité foudroyante
- Moyenne d'âge à l'intervention 65 ans

2. Omarthrose secondaire

- Cause métabolique chondrocalcinose, hémochromatose
- Post traumatique, après cal vicieux articulaire et/ou tubérosité fracture céphalo-tubérositaire négligée ou mal ostéosynthétisée
- Après luxation récidivante aggravée par chirurgie stabilisatrice arthrogène
- Aboutissement d'une arthrite ancienne
- Conséquence nécrose avasculaire tête humérale (idiopathique, corticothérapies, alcooliques)
- Rarement à une dysplasie congénitale tête humérale en hachette

D. Classification

- Classification de SAMILSON (selon la taille de l'ostéophyte huméral et/ou glénoïdien) :
 - o Stade 1 : < 3 mm
 - o Stade 2 : entre 3 et 7 mm
 - o Stade 3 : > 7 mm

E. Clinique

- Impotence fonctionnelle douloureuse
- Limitation des amplitudes articulaires, dont l'évolution est progressive
- Douleur d'horaire mécanique, déclenchée par effort, calmée par le repos
- Douleur globale ou antérieure, irradie vers face antéro-externe de l'épaule
- Amplitudes actives et passives se limitent progressivement, surtout rotation externe et abduction
- Evolue par poussées spontanément résolutive déclenchées par surutilisation de l'épaule
- A un stade avancée, douleurs nocturnes, calmés par immobilisation
- L'examen objective
 - o Limitation de la mobilité globale
 - o Craquement douloureux (mobilisation épaule)
 - o Epaule bloquée avec sensation de butée

F. Imagerie

1. Radiographie standard :

- o Les signes élémentaires d'arthrose

- o Pincement de l'interligne gléno-huméral
- o Participe au bilan étiologique
- o Rechercher cops étrangers intra-auriculaires
- o Apprécie centrage tête humérale et glène

a) Radiographie de face sensibilisée par abduction contrariée du membre supérieur :

- manœuvre consistant à mettre le bras en abduction contrariée à 20°, pour réaliser l'incidence de l'espace sous-acromial, elle permet de mieux détecter une rupture de la coiffe des rotateurs

b) Position couchée (incidence de Railhac) :

- l'incidence de Railhac permet d'analyser parfaitement l'articulation acromio-claviculaire. En cas de luxation, l'interligne articulaire est élargie et l'extrémité externe de la clavicule est déplacée en haut et en arrière.

c) Arthroscanner

- o Détecte existence rupture associée coiffe des rotateurs
- o Apprécie qualité de stock osseux glénoïdien résiduel
- o Orientation ostéophyte, parfois exubérante
- o Degré d'ostéoporose, recherche de géodes

G. Traitement

a) Initialement médical :

- antalgique, antiinflammatoire, hygiène fonctionnelle de l'épaule

b) Quand dépassé et gène +++ :

- il faut discuter l'indication chirurgicale d'une arthroplastie

c) Pour l'arthroplastie :

- o Prothèse utilisée non contraintes
- o Plus souvent prothèse totale que prothèse humérale simple
- o Dans les deux cas, tiges humérales cimentées ou sans ciment, revêtues d'un traitement de surface facilement l'incorporation osseuse

d) Technique chirurgicale

- o Arthroplasties humérales par vois delto-pectorale

- o Réinsertion proximalisée sous-scapulaire ou plastie d'allongement avec la capsule permettant de gagner 20° de rotateur externe par cm d'allongement
- Prothèses totales donnent meilleurs résultats (douleur et mobilité) que prothèse humérale simples
- Pas de prothèse totale en cas de rétroversion trop importante > 20°